

Fecha Última Actualización: 18-08-2022 15:23:32

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Luis Miguel Silva Golcio
Edad : 72a 2m 9d
Dirección : Pje Talcamavia 0348 Villa Cordillera

Rut : 5.463.728-4
Fecha Nacto: 09/06/1950
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A245500
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 9517 2765

N° Epicrisis
317852

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 28/06/2022 18:17

Días Estadía: 51

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 18/08/2022 15:08

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Dolor torácico

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Fecha Ingreso HSR: 28/06/2022
Fecha Ingreso UPC: 30/06/2022
Fecha Ingreso Sala: 04/08/2022
Contacto: Leonardo Silva (hijo): 9 9517 2765

Antecedentes:

- Antecedentes Mórbidos: (-)
- Medicamentos: (-)
- Alergias: (-)
- Antecedentes Quirúrgicos: Hemorroidectomía 2010, amputación traumática 2o y 3er orjejo mano derecha
- Hábitos: TBQ (-), OH (+) crónico, Drogas (-)
- Antecedentes Familiares: Niega
- Inmunizaciones: COVID 4 dosis
- Hospitalizaciones recientes: No

Historia:

Paciente presenta dolor torácico s/sdst con curva troponinas (+). Se inicia manejo farmacológico de IAM, evolucionando con comp. De conciencia hasta Glasgow 5, por lo que se conecta a VMI. TAC cbro evidencia gran hematoma cortical frontal izquierdo, vaciamiento ventricular, HSA de la convexidad adyacente a hematoma y en surco parietal derecho, con desviación de línea media. Motivo por el cual se suspende anticoagulación y DAP. Además se toman HCs que informan SAMS con ecoscopia en la que se aprecia vegetación en válvula aórtica. Se traslada a UPC donde se descarta resolución neuro quirúrgica. Se estabiliza hemodinámicamente, evoluciona mal del punto de vista neurológico. Se realiza TQT el 02/08 debido a compromiso de conciencia persistente, y se maneja con ATB por endocarditis. Una vez respirando espontáneo se traslada a medicina para continuar manejo.

Infeccioso:

Cursando endocarditis por SAMS, tiene:

-Ecocardiograma TT 01/07 Válvula aórtica con imágenes compatibles con vegetaciones en cara ventricular de 3x3 mm, asociadas a reflujo leve. Cavidades derechas normales. Reflujo mitral trivial. Impresiona endocarditis infecciosa, se sugiere

Fecha Epicrisis : 18/08/2022 15:23

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 18-08-2022 15:23:32

Página 2 de 3

tratamiento acorde, sin indicación quirúrgica).

-Evaluado por maxilofacial sin foco oral.

-Se sospechan infartos esplénicos y aneurismas micóticos secundarios a endocarditis.

-Se maneja inicialmente con vancomicina, gentamicina. Posterior traslape a cloxacilina. Se discutió caso con equipos de UPC y debido a mal pronóstico se suspendió terapia ATB (completa en total 30 días de ATB).

Además, cursa:

-NAVM por S. Maltophilia tratada con Cotrimoxazol

Neurológico: Paciente con mala evolución neurológica. TAC de controles evidencian el hematoma con múltiples infartos frontales y occipitales derechos. EEG sin actividad epileptiforme. Evolucionando en estado de mínima conciencia. Discutido con especialidad, les impresiona un mal pronóstico neurológico. Debido a esto se inicia lento retiro de terapias de soporte.

Ventilatorio: Intubado en contexto de compromiso de conciencia el 29/06. TAC TX control 30/06: Aparición de severo neumotórax izquierdo sin desplazamiento de estructuras mediastínicas. Por lo que el 30/06 se instala pleurostomía izquierda. Control RxTx sin neumotórax por lo que se retira. Posterior TQT respirando espontáneo.

Nutricional: Alimentándose por SNG. Sin GTT debido a mal pronóstico vital.

Se conversa con familiares y equipo médico, y dado pronóstico ominoso actual, sin posibilidad de rehabilitación, se decide adecuación del esfuerzo terapéutico, y se suspende parte de terapia médica, quedando en control de síntomas.

Diagnóstico de Egreso

Endocarditis Aguda, No Especificada -

Hematoma Frontal Izquierdo -

Tqt -

Trastorno De Deglución -

Condición de Egreso Alta Derivado al Hospital San José de Maipo

Egreso con Catéter Doble J:NO

En estado de mínima conciencia. Se decide traslado a Hospital San José de Maipo para continuar cuidado. Familiares no están en condición de cuidarlo.

Plan Post Alta

Indicaciones de Traslado:

Reposo Relativo

Régimen licuado por Sonda Nasogástrica, poner alimentos en licuadoras hasta consistencia líquida, luego administrar por Sonda. Posteriormente realizar aseo de sonda con agua

Aseo bucal 3 veces al día

Medicamentos:

Paracetamol 1g cada 8 horas por SNG

Omeprazol 20 mg al día por SNG

Levetiracetam 1g cada 12 horas por SNG

Si fiebre: Metamizol 300 mg por SNG, máximo cada 8 horas

Acudir al Servicio de Urgencias:

Dado paciente con pronóstico limitado, se sugiere consulta en servicio de urgencias sólo si se estima conveniente

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Sng, Fresubin A 40 Cc/H

Medicamentos : Paracetamol 1 Gr C/8 Hrs X Sng
Omeprazol 20 Mg C/D X Sng

Fecha Epicrisis : 18/08/2022 15:23

Página 2 de 3



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 18-08-2022 15:23:32

Página 3 de 3

Levetiracetam 1 Gr C/12 Hrs X Sng

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Pedro Pablo Donoso Lagos

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 18/08/2022 15:23

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:58

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar